TOME 06 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Urgences & Réanimation

Collège Français de Médecine d'Urgence & Réanimation (CFMU) • 260 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 06 : Urgences & Réanimation.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 260 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collège Français de Médecine d'Urgence & Réanimation (CFMU).
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	260 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 06

Collège Français de Médecine d'Urgence & Réanimation (CFMU) • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 06 • Urgences & Réanimation (260 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

PARTIE 1 — SITUATIONS D'URGENCE

- Chapitre 01 : Coma non traumatique (336)
- Chapitre 02 : Détresse et Insuffisance respiratoire aiguë (359)
- Chapitre 03 : Oedème de Quincke et anaphylaxie (338)
- Chapitre 04 : Arrêt cardiaque (331)
- Chapitre 05 : État de choc (332)
- Chapitre 06 : Sepsis, Choc septique (158)
- Chapitre 07 : Intoxications aiguës (337)
- Chapitre 08 : Situations sanitaires exceptionnelles (333)
- Chapitre 09 : Prise en charge du traumatisé (334)
- Chapitre 10 : Traumatisme crânien (335)
- Chapitre 11 : Hyperthermie
- Chapitre 12 : Hypothermie

PARTIE 1

SITUATIONS D'URGENCE

- Chapitre 01 — Coma non traumatique (336)
- Conscience (rang C dans la 7e edition neuro)
- Schéma
- Conscience est un concept complexe qui peut-e■tre sche■matiquement divise■ en 2 composantes :
- Diagnostic différentiel (rang C)
- Prise en charge du patient dans le coma
- Traitements de 1ère ligne chez un patient dans le coma
- Rappel (signes évocateurs d'engagement)
- Manifestations devant faire évoquer un engagement ■
- Évaluation neurologique d'un patient dans le coma
- Réactivité à la douleur
- Examen des yeux chez le patient dans le coma
- Fonction ventilatoire

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

PARTIE 1 — SITUATIONS D'URGENCE

Chapitre 01 : Coma non traumatique (336)
Chapitre 02 : Détresse et Insuffisance respiratoire aiguë (359)
Chapitre 03 : Oedème de Quincke et anaphylaxie (338)
Chapitre 04 : Arrêt cardiaque (331)
Chapitre 05 : État de choc (332)
Chapitre 06 : Sepsis, Choc septique (158)
Chapitre 07 : Intoxications aiguës (337)
Chapitre 08 : Situations sanitaires exceptionnelles (333)
Chapitre 09 : Prise en charge du traumatisé (334)
Chapitre 10 : Traumatisme crânien (335)
Chapitre 11 : Hyperthermie
Chapitre 12 : Hypothermie

PARTIE 1

SITUATIONS D'URGENCE

Chapitre 01 — Coma non traumatique (336)
Conscience (rang C dans la 7e edition neuro)

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Urgences & Réanimation

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Éveil	Éveil (ou vigilance, wakefulness ou arousal en anglais), est sous le contro■le de neurones situe■s dans le tronc ce■re■bral (substance re■ticule■e activatrice ascendante), dans la partie poste■rieure du pont et du me■sence■phale, ainsi que dans la partie poste■ro-ante■rieure du dience■phale (noyau de Meynert). Ces noyaux re■gulent le niveau de vigilance (e■veil, sommeil lent, sommeil paradoxal) par des projections diffuses vers l'ensemble du cortex ce■re■bral (directes ou relaye■es par les noyaux re■ticulaires du thalamus
Contenu conscient	Contenu conscient (conscience de soi, de l'environnement, awareness en anglais) sous-tendu par un syste■me organise■ en re■seau dont le substrat anatomique reste de■battu, mais qui implique des neurones a■ connexion longue distance, situe■s en grande partie dans les re■gions associatives pre■-frontales et parie■tales

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Urgences & Réanimation

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Définition	Coma est de■fini par une suppression de la vigilance (ou e■veil, qui est une composante de la conscience) - Peut être reversée par un stimulus auditif ou douloureux, sauf si coma dépassé - Il peut apparaître d'emblée ou faire suite à une obnubilation ou à une stupeur
Obnubilation	En cas d'obnubilation, il persiste une re■action aux ordres complexes : le patient re■pond a■ un ordre oral et e■crit, exe■cute les ordres, l'orientation temporospatiale est normale, la re■activite■ moins rapide et moins pre■cise
État suporeux	Lors d'un e■tat stuporeux, la re■activite■ a■ des stimuli exte■roceptifs simples persiste (appel du nom, stimulation auditive, stimulation nociceptive), la re■ponse obtenue est un geste ou une parole
Physiopath.	Coma traduit une défaillance de la formation réticulée activatrice ascendante (FRAA) du tronc cérébral : - Localisation : partie postérieure du pont et du mésencéphale et partie postéro-antérieure du diencéphale) - Rôle : support neurophysiologique de la vigilance - Il existe aussi d'autres relais de la vigilance : -> Hypothalamus : rôle dans la régulation métabolique, hormonale et thermique (= 1er relais du réseau de la vigilance centré sur la FRAA) -> Thalamus : ainsi une lésion thalamique bilatérale doit être recherchée devant trouble de la vigilance (= 2nd relais entre la FRAA et le cortex cérébral) -> Cortex cérébral : implique les fonctions supérieures dans le maintient de la vigilance (attentionnelles ++) - Causes du coma : -> Soit souffrance cérébrale diffuse (ex. toxique, métabolique, traumatique, infectieuse, épileptique) -> Soit lésion cérébrale focale sous-tentorielle (lésion directe du FRAA) ou sus-tentorielle

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 06

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 06 • Urgences & Réanimation (260 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collège Français de Médecine d'Urgence & Réanimation (CFMU)
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (260 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.